TOME 28 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Génétique Médicale

Collège des Enseignants de Génétique Médicale • 72 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 28 : Génétique Médicale.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 72 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collège des Enseignants de Génétique Médicale.
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	72 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 28

Collège des Enseignants de Génétique Médicale • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 28 • Génétique Médicale (72 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

PARTIE 1 — ITEMS EDN

- Chapitre 01 : Trisomie 21 (45)
- Chapitre 02 : Syndrome de l'X fragile (45)
- Chapitre 03 : Mucoviscidose (45)
- Chapitre 04 : Maladies rares (22)
- Chapitre 05 : Médecine génomique (46)

PARTIE 2 — RAPPELS DE COURS EN GÉNÉTIQUE

PARTIE 1

ITEMS EDN

- Chapitre 01 — Trisomie 21 (45)
- Diagnostic positif
- Tableau clinique
- Dysmorphie dans la trisomie 21
- Malformations dans la trisomie 21
- Complications de la Trisomie 21 (chiffres d'incidence sont donnés à titre indicatif)
- Présentation du diagnostic selon l'âge
- A la naissance
- • Évaluation de l'hypotonie (faiblesse musculaire).
- • Rechercher une cardiopathie.
- • Rechercher des difficultés alimentaires avec troubles de la déglutition (troubles de l'oralité pouvant nécessiter une rééducation par une orthophoniste).
- • Repérer les régurgitations (reflux gastro-œsophagiens ou RGO).
- • Interroger sur les troubles du transit : constipation fréquente.
- • Suivre la croissance : retard de croissance staturo-pondéral attendu sur -2 DS.
- • Rechercher une hypoacousie ou surdité (potentiels évoqués auditifs précoces en systématique actuellement).
- • Rechercher une cataracte congénitale.
- Chez le nourrisson
- • Suivi de l'alimentation et de la croissance staturo-pondérale.
- • Prise en charge d'un allaitement normal et difficile (troubles de l'oralité). Allaitement maternel possible, mais souvent plus difficile.

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

PARTIE 1 — ITEMS EDN
Chapitre 01 : Trisomie 21 (45)
Chapitre 02 : Syndrome de l’X fragile (45)
Chapitre 03 : Mucoviscidose (45)
Chapitre 04 : Maladies rares (22)
Chapitre 05 : Médecine génomique (46)
PARTIE 2 — RAPPELS DE COURS EN GÉNÉTIQUE
PARTIE 1

PARTIE 1

ITEMS EDN

Chapitre 01 — Trisomie 21 (45)

Diagnostic positif

Tableau clinique

Dysmorphie dans la trisomie 21

Malformations dans la trisomie 21

Complications de la Trisomie 21 (chiffres d’incidence sont donnés à titre indicatif)

Présentation du diagnostic selon l’âge

A la naissance

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Génétique Médicale

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Autre nom	Syndrome de Down
Prévalence	Maladie ge■ne■tique fre■quente, touche 1 fœtus sur 700
Incidence annuelle	En raison du diagnostic prénatal : 1 pour 2000 naissances
Anomalie	Forme la plus fréquente = pre■sence d'un chromosome 21 surnume■raire (trisomie 21 libre) transmis dans 90% des cas par la me■re
FR	Seul FR connu pour la survenue d'une trisomie 21 = a■ge maternel

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Génétique Médicale

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Tableau	- Aucun signe pathognomonique [X] - Hypotonie marquée = seule manifestation quasi-constante, mais non spécifique - Triade phénotypique de toute anomalie chromosomique (inconstant, phénotype variable) : -> Retard psychomoteur -> Dysmorphie : re■sulte de l'accumulation chez un me■me individu de particularite■s morphologiques mineures et non spe■cifiques -> Malformation : sont souvent identifiées avant la naissance
MAI	Penser aux Maladies auto-immunes
Non	Malformations congénitales ne sont pas constantes
Enjeux	Reconnaître une trisomie 21 peut s'avérer difficile, en particulier dans un contexte ethnique non familier Sujets trisomiques 21 ont des difficultés à décrire leurs symptômes ou à localiser et quantifier leurs douleurs, le diagnostic des complications peut donc être retardé ou négligé et les bilans systématiques sont importants, mais une attention particulière doit être prêtée aux changements de l'humeur, aux modifications inattendues de poids ... -> qui peuvent signer une complication secondaire

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 28

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 28 • Génétique Médicale (72 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collège des Enseignants de Génétique Médicale
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (72 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.